

Fecha Última Actualización: 27-08-2022 6:46:47

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Julio Miguel Leiva Rojas
Edad : 57a 10m 6d
Dirección : Rio Lauca 1739 Dpto. 1739

Rut : 9.966.725-7
Fecha Nacto: 20/10/1964
Comuna : Peñalolen

N° Archivo : 2214214
Sexo : Masculino
Teléfono : 966740002

N° Epicrisis
315429

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Emergencia Adulto

Fecha Ingreso : 16/07/2022 14:45

Días Estadía : 41

Unidad de Egreso : Utac/ Utinx

Fecha Egreso : 26/08/2022 18:26

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Infarto ACM derecha, oclusión ACM derecha

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

RESUMEN DE TRASLADO

Fecha de ingreso a CASR: 16/07/22
Fecha de ingreso a UCI: 16/07/22
Fecha de ingreso a UTAC: 29/07/2022

Antecedentes:

- Funcionalidad: Zurdo, mRankin 0, educación carrera técnica: topografía (construcción)
- Mórbidos: Hipertensión arterial
- Fármacos: Losartán (se desconoce adherencia)
- Cirugías: laparotomía por herida penetrante accidental abdominal en adolescencia
- Hábitos: tabaquismo no, alcohol no, drogas no
- Alergias: no a medio de contraste yodado
- Social: Vivía con pareja, en este instante su contacto más cercano es su hermana, fono contacto: 966740002 (Patricia)

Anamnesis:

Paciente con antecedentes descritos. Datos obtenidos de ficha médica, sin familiares al momento del ingreso. Cuadro de inicio súbito el 16/7 a las 9 AM caracterizado por afasia global más hemiparesia izquierda. Acudió en primera instancia a APS donde fue derivado a Hospital La Florida, ingresando a las 11:11 hrs. Fue evaluado por Equipo Neurología de dicho centro, donde se solicitó TC Cerebro. Dada sedación para toma de imágenes, perdió protección de vía aérea y se intubó. TC Cerebro mostró signos precoces de infarto en territorio ACM derecha (ASPECTS 6). AngioTC con oclusión de M1 derecha en su tercio medio a distal y oclusión desde el origen de arteria vertebral derecha con llene del segmento V4 ipsilateral. NIHSS 18 (0-2-2-2-0-20-2-0-0-1-3-2-0). Por ASPECTS, se decidió no trombolizar, por lo que se solicitó traslado a HSR para trombectomía mecánica, ingresando a las 13:20hrs, trasladándose directamente a angiógrafo, con tiempo puerta ingre de 31 minutos. Se realizó trombectomía por aspiración logrando reperusión TICI 3 luego de 1 intento.

El paciente egresó a recuperación y posteriormente a UPC.

EVOLUCIÓN EN UPC:

1. Hemodinamia: En UPC se mantuvo con sedación para manejo de hiperadrenergia y mantener metas de PA en rango de

Fecha Epicrisis : 27/08/2022 06:46

Página 1 de 5

neuroprotección. El 20/7 se inició retiro de sedoanalgesia en relación a lo cual presentó HTA. Se inició gradualmente tto antihipertensivo con Amlodipino, Losartán e Hidralazina. Al momento del traslado solo con Losartán pero con mal control de PA.

2. Neurológico. El paciente ingresó bajo sedación farmacológica. Se indicaron medidas de neuroprotección y terapia osmótica por riesgo de evolución maligna. Durante las primeras 24 horas evolucionó con signo de Babinski bilateral por lo que se controló con un TC de encéfalo urgente que evidenció extenso infarto de ACM derecha con efecto de masa y desviación de línea media. Se presentó el caso a neurocirugía decidiéndose una craniectomía descompresiva derecha la cual se realizó el 17/7 sin incidentes descritos. El paciente retornó a UPC donde se mantuvo con terapia osmótica transitoriamente. Se inició atorvastatina. Se controló un nuevo TC (17/7) donde se observaron cambios de la craniectomía, con herniación cerebral por la misma y transformación hemorrágica tipo PH1. Se complementó el estudio con un EEG (18/7) que fue informado con lentitud continua hemisférica derecha, sin actividad epileptiforme. Se decidió retiro de la sedación en relación a lo cual evolucionó con agitación y signos de hiperadrenergia. Por ello se inició quetiapina e infusión de dexmedetomidina transitoriamente. El 22/7 se repitió TC de encéfalo sin contraste que mostró el infarto ya conocido, con herniación por la craniectomía y transformación hemorrágica. Adicionalmente se observó hipodensidad talámica anterior izquierda y de territorio arteria cerebral posterior izquierda que retrospectivamente ya estaban presentes en el TC inicial (pendiente informe). Por el compromiso de conciencia se adicionó empíricamente Fenitoína el 23/7. El 26/7 se repitió EEG que informó lentitud continua polimorfa hemisférica derecha y atenuación de voltaje relativa hemisférica izquierda. Dado este hallazgo se decidió retiro de fenitoína el 26/7. Se realizó nuevo TC de control el 27/7 que impresionó sin cambios por lo que se indicó aspirina y trombopprofilaxis farmacológica. El 28/7 se describe en sopor medio, sin conectarse, sin obedecer órdenes ni vocalizar lenguaje, hemianopsia izquierda, mirada central, corneal dism a izquierda, PFC izquierda, hemiplejía izquierda y Babinski ipsilateral. Se repitió EEG el 28/7 que fue informado con frecuente lentitud intermitente hemisférica izquierda y lentitud polimorfa hemisférica izquierda más atenuación de voltaje hemisférica del mismo lado

3. Infeccioso: Por antecedente de intubación de emergencia y posible aspiración se indicó terapia antibiótica empírica con ampicilina/sulbactam. Se estudió con TC de tórax (17/7) que informó signos de bronquiolitis celular en segmentos dependientes de ambos pulmones, más confluentes en LII formando focos de relleno alveolar de aspecto neumónico. El paciente presentó buena respuesta inicial, sin embargo al 5to día de tratamiento evolucionó febril hasta 38,2, con elevación de los parámetros inflamatorios (PCR 512 - 143). Se pancultivó el 21/07 resultando todo negativo (urocultivo, cultivo de aspiración endotraqueal, hemocultivos, cultivo cuantitativo de catéter). Completó 7 días de unasyn. Posterior a ello evolucionó con persistencia de episodios febriles. El 25/7 se pancultivó nuevamente destacando un CAET con cocos Gram positivos (CGP) y bacilos Gram negativos (BGN) por lo que se inició meropenem + vancomicina. Resto de cultivos (UC, HC, cuant de cateter) negativos. Se controló TC tórax el 27/7 informado con resolución del foco de relleno alveolar. El 27/7 se recibió cultivo de aspirado traqueal + para K oxytoca por lo que se desescaló a ampicilina/sulbactam.

4. Respiratorio: Difícil destete de la sedación por agitación, taquipnea e hiperadrenergia en relación a su retiro. Por ello se decidió traqueostomía quirúrgica con objeto de avanzar en weaning. Se realizó el 27/7 sin incidentes.

5. Hidroelectrolítico: Inicialmente hipernatremia por uso de S hipertónico. Presentó hipokalemia atribuida a episodios de emesis que corrigió con aporte IV de KCl. Posteriormente sin conflictos desde este punto de vista.

EVOLUCIÓN EN UTAC:

1. Hemodinámico: estable, se mantuvo con presiones elevadas, las cuales se manejaron con Losartan 50mg/día y amlodipino 10 mg/día. En cuanto a las crisis adrenérgicas se inició una BIC de morfina de 0,5 mg/h, se redujo gradualmente hasta su suspensión el 09/08. Sin nuevas crisis. Posteriormente evolucionó con tendencia a la taquicardia sinusal, se realizó AngioTC tórax del 03/08 sin TEP. Se mantuvo en observación y se solicitó medición de balances hídricos (por orina abundante).

2. Neurológico: Paciente ingresó con NIHSS 28 que se ha mantenido estable, sin nuevos déficits neurológicos. Evolucionó con compromiso de conciencia, el 30/7 se discutió hallazgos de EEG con epileptólogo y llamó la atención lentitud intermitente izquierda y depresión de voltaje ipsilateral por lo que se inició levetiracetam. Monitoreo EEG del 31/7 ocasional AE interictal anterior derecha, lentitud central derecha y disfunción lenta continúa generalizada. Se mantiene levetiracetam 1g c/12 h. Ha evolucionado estable, sin eventos sugerentes de crisis. Se mantuvo prevención secundaria con AAS y atorvastatina, esta última debiendo suspenderse el 13/8 por alteración del perfil hepático.

Se completó con el siguiente estudio etiológico:

Fecha Epicrisis : 27/08/2022 06:46

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 27-08-2022 6:46:47

Página 3 de 5

- FRCV: LDL 77, TG 176, B12 505, TSH 2.57, HA1C 6.5%, VDRL NR
- Estudio de fuente embólica se solicitó pero no se realizaron porque paciente no es candidato a anticoagulación.
- Ttno de deglución grave, se realiza GTT el día 26/08/2022 culminando a las 12h30 sin inconvenientes

3. Rehabilitación

- KNT: SBC con máxima asistencia mal control de tronco.
- FNA: disfagia severa. Día 18/08 fue a Gastrostomía (GTT) pero no se realizó por tos, presencia de contenido gástrico (a pesar de estar en régimen cero) y por cicatriz de calota en abdomen. Se realiza segundo intento el día 26/08 sin inconvenientes, para iniciar lentamente alimentación a las 6 horas de instalada

4. Infeccioso

- Paciente cursó con neumonía aspirativa y NAVMpor CAET K oxytoca (25/7), en tratamiento con ampicilina + sulbactam y luego meropenem + vancomicina, con regular respuesta. El 30/7 se pancultivo e incremento dosis para cobertura meníngea. El 4/8 con diarrea, CD (+), se trató con vancomicina oral 125 mg cada 6 horas por 2 semanas. TC 03/8 y RM 4/7 con captación de contraste y gad con realce leptomeníngeo, sin embargo se informa sin absceso. Evaluado por neurocirugía e infectología sugieren mantener antibióticos por 2 semanas y reevaluar con nueva RM que se realizó el día 25/08 (pendiente informe). El 21/8 tuvo nuevo peak febril, se pesquiza una flebitis por lo que se suspendió la Vancomicina y se inició Linezolid. Además tiene un CAET con PSA S a cipro.
- Reevaluado por infectología el día 25/08 sugiere mantener Meropenem/ Linezolid, solicitar una RxTx para decidir inicio de ciprofloxacino y definir tiempo de tto ATB con informe de la RM de cerebro. Rx realizada el 26/08 sin signos de condensación, sin hallazgos relevantes
- Última microbiología 2/8 CVC y HC 1 y 2, periférico (-), 3/8 HC 1 y 2 (-), 5/8 CD (+), 9/8 HC (-), 10/8 CAET candida. NP Vanco 11/8 53, 12/8 9.6, 16/8 18.9.

5. Respiratorio:

TQT in situ, se cambió TQT 4/8. Con menor sialorrea y buena mecánica respiratoria. Presentó episodios de agitación psicomotriz, hiperadrenergia y dificultad respiratoria, se inició colutorio de atropina y bromuro de ipratropio, con regular respuesta. Considerar si iniciar toxina botulínica.

6. Nutricional:

Paciente con desnutrición, se inició Fresubin HP a 50 cc/hr x SNG (1060 cc /d). Control de parámetros nutricionales c/8 días. Último control 16/8 con hipoalbuminemia leve e hipofosfemia (1.7). Se indicó carga de fosfato monopotásico, con control en 3,2. Fue reevaluado por nutrición quienes estuvieron de acuerdo con cambiar fórmula a Diben 1.5 a 50 ml/h (aporta 30 kcal/kg y 1,5 gr, mismo aporte de fórmula anterior pero permite mejor control glicémico). Además sugirieron continuar con monitoreo de ELP, parámetros nutricionales seriados, fosfemia y realizar cargas externas según niveles. Paciente con residuos gástricos a pesar de estar en régimen cero, se indicó metoclopramida horario. Considerar control de electrolitos tras el inicio de alimentación por GTT por riesgo de síndrome de realimentación.

7. Hepático:

En UTAC cursó con elevación de transaminasas, que se mantuvieron pese a la suspensión de Atorvastatina el 13/8. Se interpretó como probable DILI secundario a antibióticos. De todas maneras se solicitó Ecografía abdominal (Pendiente). últimas pruebas hepáticas 18/08 con mejoría: GGT 357, FA 354, BiliT 0.43, GPT 302.

8. Metabólico:

Con mal control glicémico, se decidió inicio de NPH actualmente recibiendo 18-14 UI y se cambió alimentación enteral de Fresubin HP a Diben 1.5 con buena respuesta. Se mantiene en ajuste.

9. Hidroelectrolítico:

El 16/08 en control de exámenes destacó alza de BUN con hipernatremia de 149 atribuida a VEC bajo. Se indicó Ringer lactato y agua libre por SNG. Sodio de control en 150, se aumentó agua libre por SNG con buena respuesta, control de natremia en 144. Además evolucionó con hiperkalemia 5.95, se indicó furosemida 20 mg al día ev.

10. Otros: el día 10/08 se detectó una UPP en gluteo derecho grado 2. Se realizaron curaciones y se aplicó parche de parafina. Se indicó movilización c/2 h al equipo de enfermería. Se mantuvo con tromboprolaxis y profilaxis de sangrado digestivo.

Se discute con la familia proporcionalidad de manejo médico, no IOT, VMI, manejo hasta intermedio.

Fecha Epicrisis : 27/08/2022 06:46

Página 3 de 5

Diagnóstico de Egreso

Infarto Cerebral Extenso Territorio De Art Cerebral Media Derecha -
Oclusión De Arteria Cerebral Media Derecha En Segmento M1 -
Trombectomía Mecánica De Segmento M1 Derecho Con Tici 3 Resultante -
Comportamiento Maligno De Infarto Cerebral De Acm Derecha -
Craniectomía Descompresiva Derecha + Plaqueta En Bolsillo Abdominal -
Infartos Con Transformación Hemorrágica -
Epilepsia Sintomática Secundaria -
Crisis Hiperadrenérgicas Paroxísticas Resueltas -
Sospecha De Cerebritis En Tratamiento Antibiótico -
Síndrome Diarreico Con Toxina Clostridium Positivo Tratada -
Infección Vías Urinarias Tratadas -
Flebitis Extremidad Superior Derecha En Tratamiento -
Desnutrición Proteocalórica -
Hipertensión arterial -
Diabetes mellitus 2 -
Drug-Induced Liver Injury (Dili) -
Lesión Por Presión (Lpp) -
Intubación Prolongada: Traqueostomía (No 8, Con Puerto Subglótico Y Endocánula) -

Condición de Egreso Alta Otro Destino

Egreso con Catéter Doble J:NO

SV: PA 131/85 mmHg, FC 120 lpm, FR 29 rpm, T°36.4, Sat 96% ambiental.

Examen Físico actual:

Bien hidratado y perfundido

Yugulares no ingurgitadas

RR2TSS

MP+SRA

Abdomen BDI, RHA+, cicatriz de bolsillo de craniectomía sana.

Sin edema ni signos de TVP

Neurológico

Vigil, ocasionalmente sigue con la mirada, escasa conexión con examinador, no emite lenguaje y no obedece órdenes.

Isocoria, RFM +/+, mirada a derecha que no vence LM, PFC izquierda, corneal disminuido a izquierda.

Pleja hemicuerpo izquierdo. Moviliza HC derecho de forma espontánea. Plantar extensor izquierdo

Hemihipoestesia izquierda.

Cerebeloso no evaluable.

NIHSS 0-2-2-2-0/2-4-0-4-0/0-1-3-2-0= 22

mRs al momento del traslado: 5

Plan Post Alta

Reposo: Sentar a sillón.

Oxigenoterapia: SOS para saturar > 93%

Régimen: Por el momento iniciar lentamente con Diben 1.5 a 20 cc/h según tolerancia y aumentar lentamente hasta Diben 1.5 a 50 cc/hra + agua libre a 50 cc/hra por gastrostomía (GTT)

Rehabilitación: KNT, FNA, TO

Hemoglucotest c/8h. Balance hídrico cada 12 horas. Cambio de posición cada 2 horas. Curación UPP SOS.

Mantener invasivos: VVP, sonda foley, CVC yug izquierdo, TQT.

FÁRMACOS

Suero premezclado 60 cc/h IV (mientras está en régimen cero o con poca ingesta).

Metoclopramida 10 mg cada 8 horas por GTT

Meropenem 2 gramos cada 8 horas (FI 30/07) IV

Linezolid 600 mg cada 8 horas (FI 24/08) IV

Fecha Epicrisis : 27/08/2022 06:46

Fecha Última Actualización: 27-08-2022 6:46:47

Página 5 de 5

Levetiracetam 1 gramo cada 12 horas GTT
Furosemida 20 mg al día EV
Aspirina 100 mg diarios GTT
Losartán 50 mg cada 12 horas GTT
Amlodipino 10mg al día GTT
Paracetamol 1 gramo cada 8 horas SOS si fiebre o dolor por GTT
Colutorio de atropina (1 mg en 9 cc de SF), dar 1 ml cada 6 horas
Famotidina 40 mg/día por GTT
Enoxaparina 40 mg día SC
Bromuro de ipratropio 2 puff cada 6 horas
Insulina NPH 18 UI AM-14 UI PM SC
Si PA > 180/105, Labetalol 10 mg IV
Si HGT > 180, insulina cristalina SC

PENDIENTES.

Rescatar informe RMN de cerebro realizada el día 25/08 en HSR (realizarlo mediante enfermero gestión de camas)
Inicio gradual de alimentación
Seguimiento con pruebas hepáticas, renales
Seguimiento por infectología

Indicaciones

Tipo de Reposo :

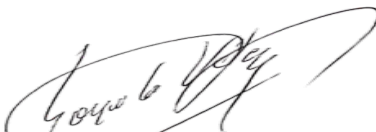
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Bec. Bernardita Vicuña Piedrabue

BECADO



Gonzalo Vélez Macías

Becado/Residente



Andres Felipe Silva Pozo

Médico Tratante (Staff)